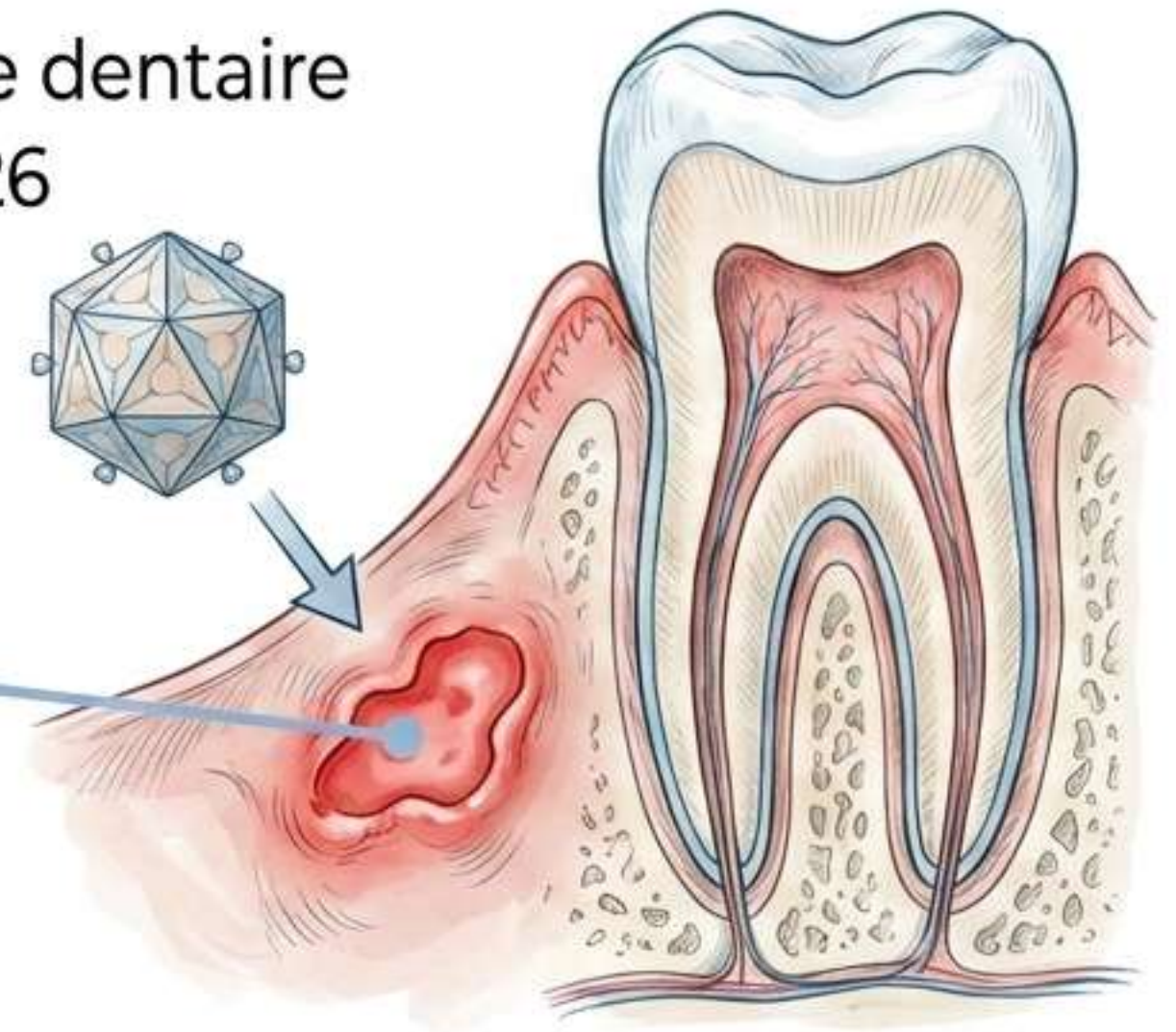


Physiopathologie des Infections Virales

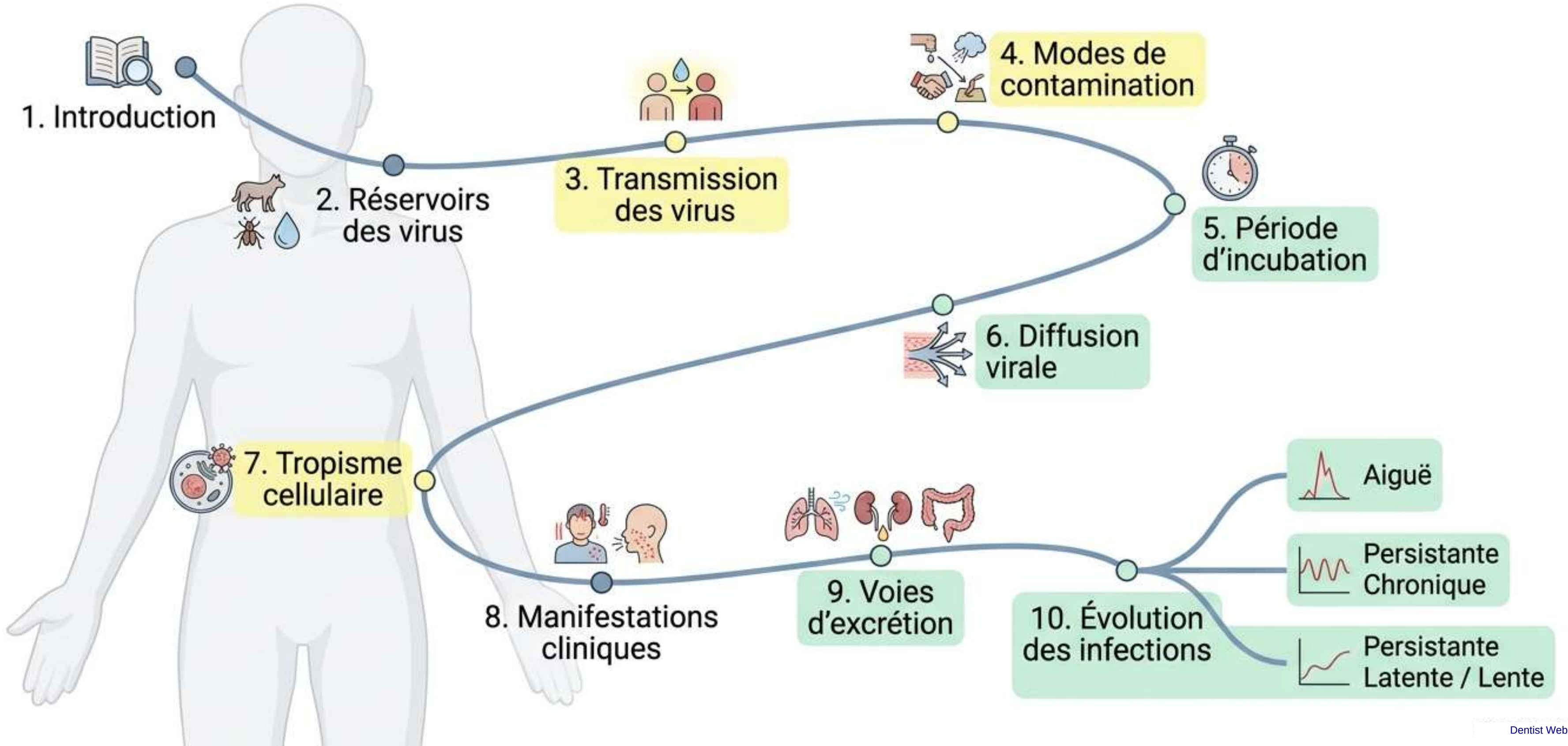
Dr Aicha BENSALEM

Cours graduation 2è année Médecine dentaire
Année universitaire 2025-2026

Objectif Principal : Comprendre comment les virus peuvent produire des lésions dans la cavité buccale.



Plan du Cours : Le Voyage Viral



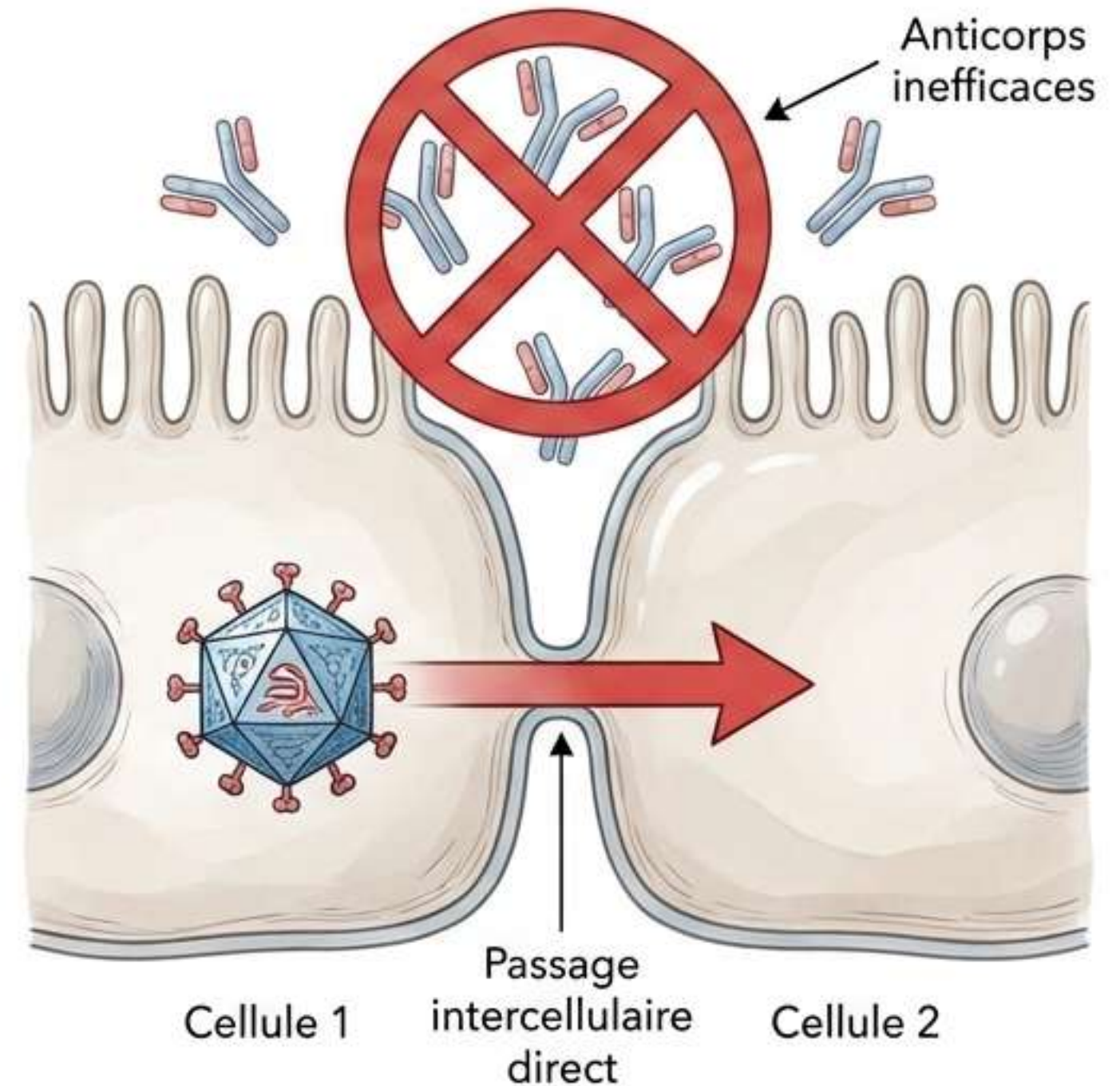
Généralités : Parasitisme et Évasion

Définition stricte :

Un virus est un **parasite intracellulaire obligatoire** qui détourne à son profit les fonctions fondamentales de la cellule qu'il infecte.

Un virus peut passer de cellule en cellule sans sortir dans le milieu extracellulaire. Il peut-être à l'abri de l'immunité humorale (anticorps) extra cellulaire.

[Predicted - Concept fondamental sur les mécanismes d'échappement immunitaire]



Initiation de l'Infection et Cascade d'Invasion

Entrée dans la cavité buccale suivie de **destructions tissulaires** (ulcérations, vésicules).

Infection locale

Le virus se multiplie exclusivement au niveau du site d'entrée (Exemple : Herpesviridae).

Infection systémique

Le virus se multiplie dans des tissus distants de la porte d'entrée impactant la santé buccale (Exemples : virus des hépatites, VIH).

1- Invasion de l'organisme par un virus

Pénétration

Diffusion

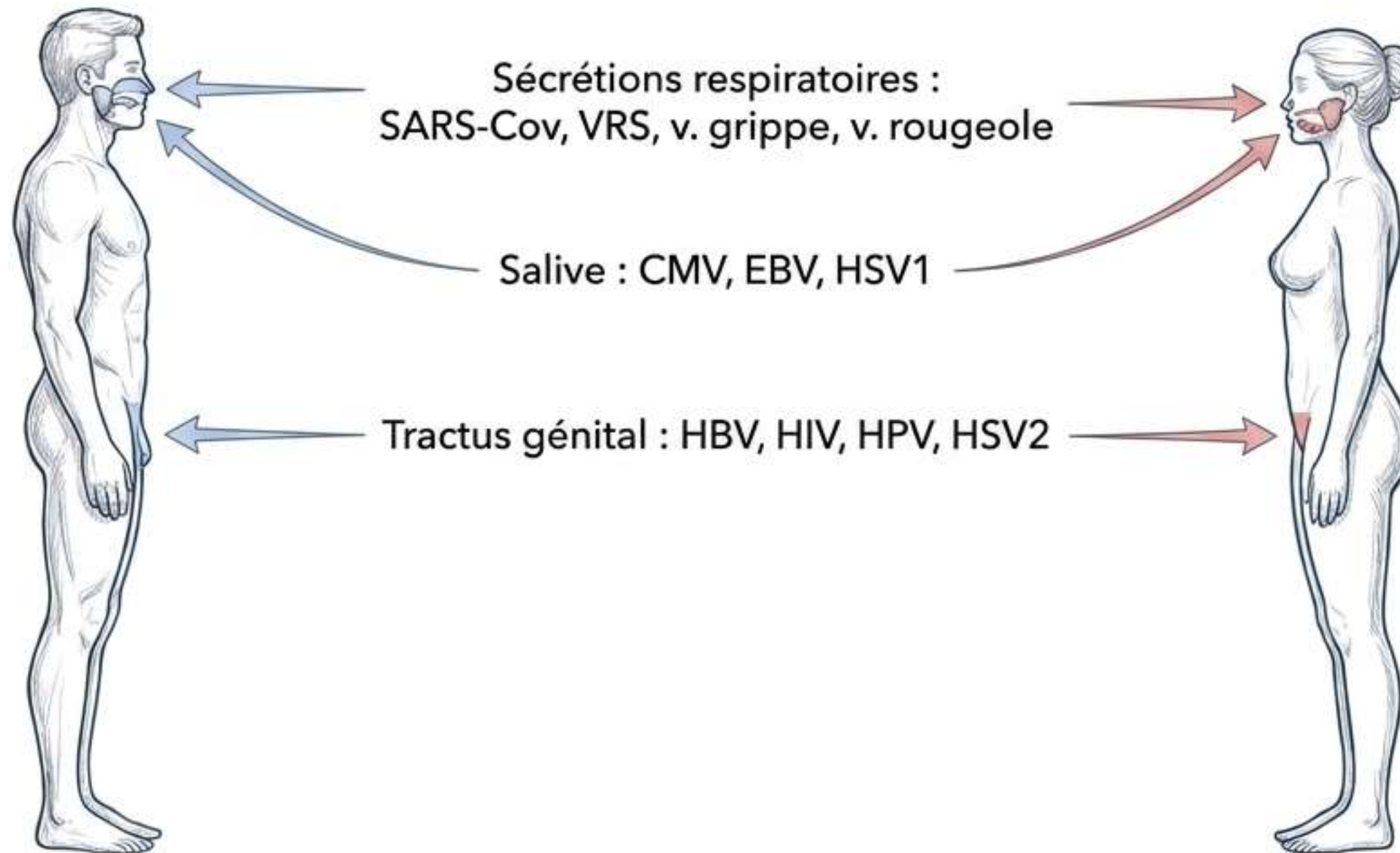
Tropisme cellulaire

Infection virale

Réservoirs des Virus Pathogènes : Focus Humain

L'Homme : principal réservoir.

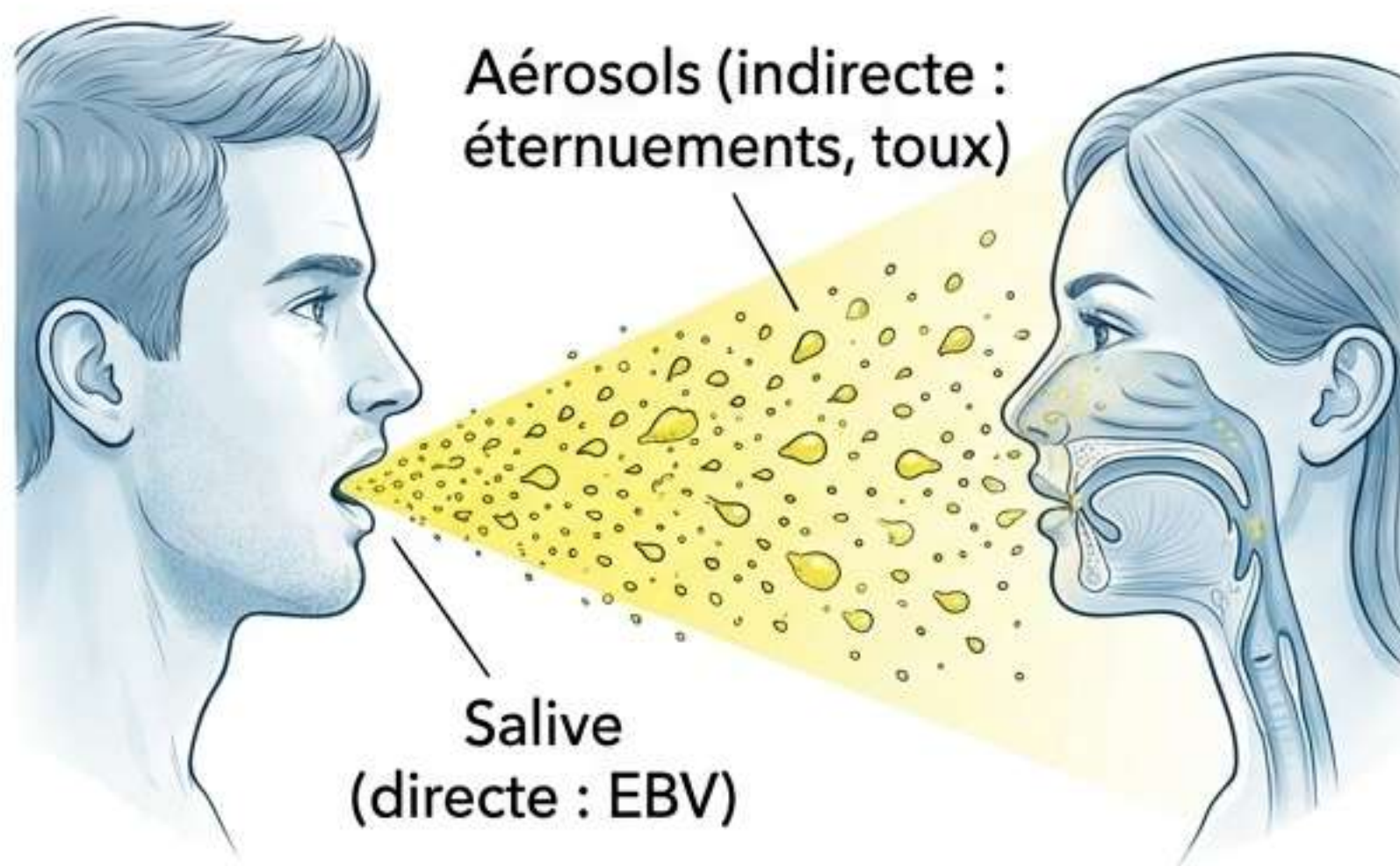
[Ref: Q8 - Piège d'examen : L'animal n'est pas le réservoir principal pour ces virus humains].



La Transmission et Modes de Contamination

Transmission : À travers une porte d'entrée par contact direct avec les muqueuses et la peau par les fluides biologiques (Salive, Contenu vésiculaire, Sécrétions génitales). [Ref: Q1]

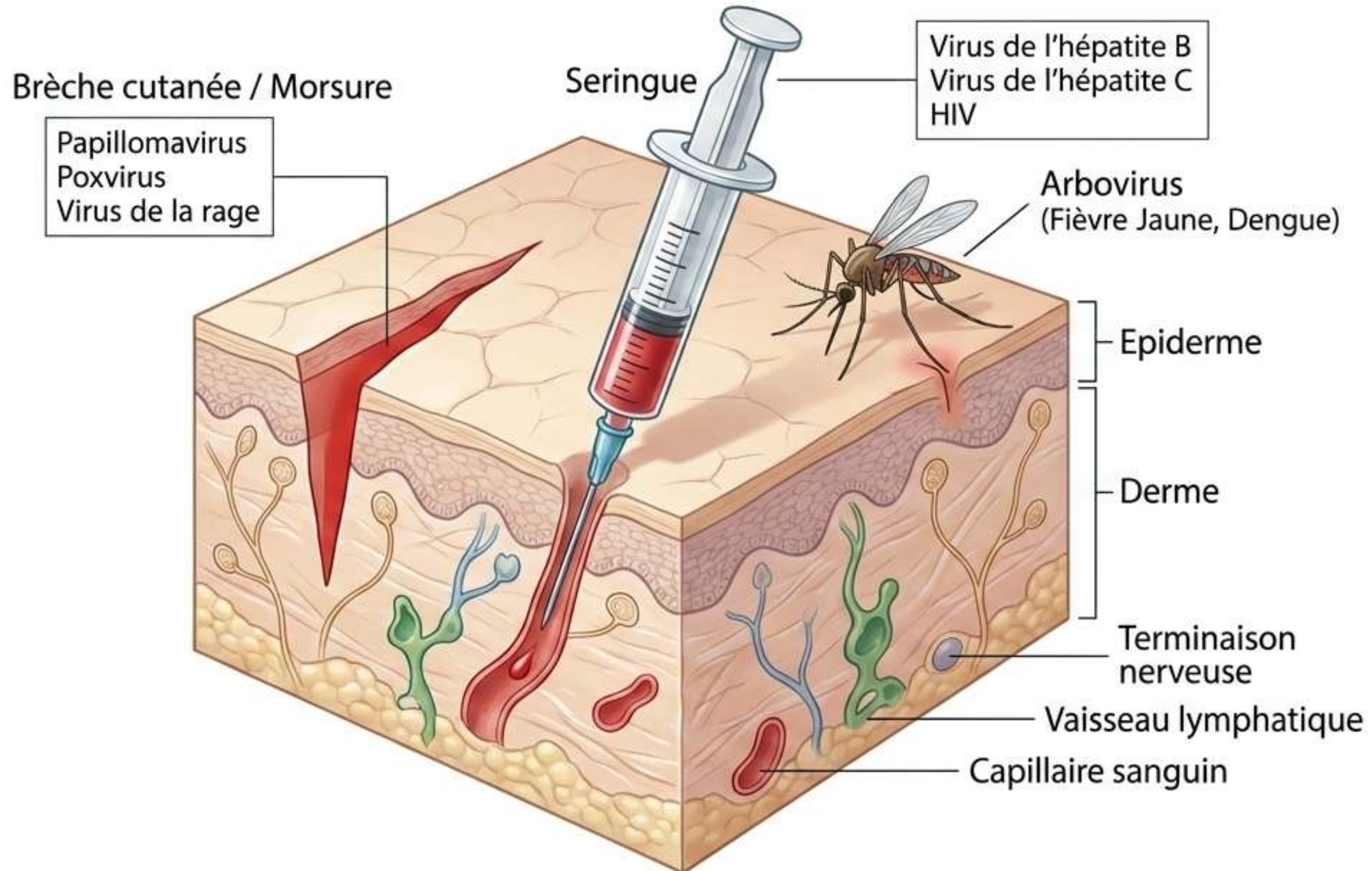
Contamination Aérienne



Autres Modes

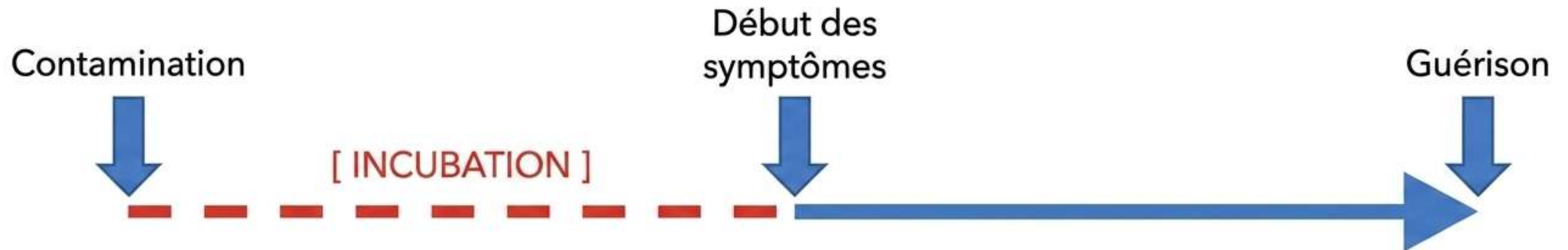


Modes de Transmission : Portes d'Entrée Transcutanées



Cinétique : La Période d'Incubation

Période silencieuse allant du contagé à l'apparition des premiers signes cliniques.



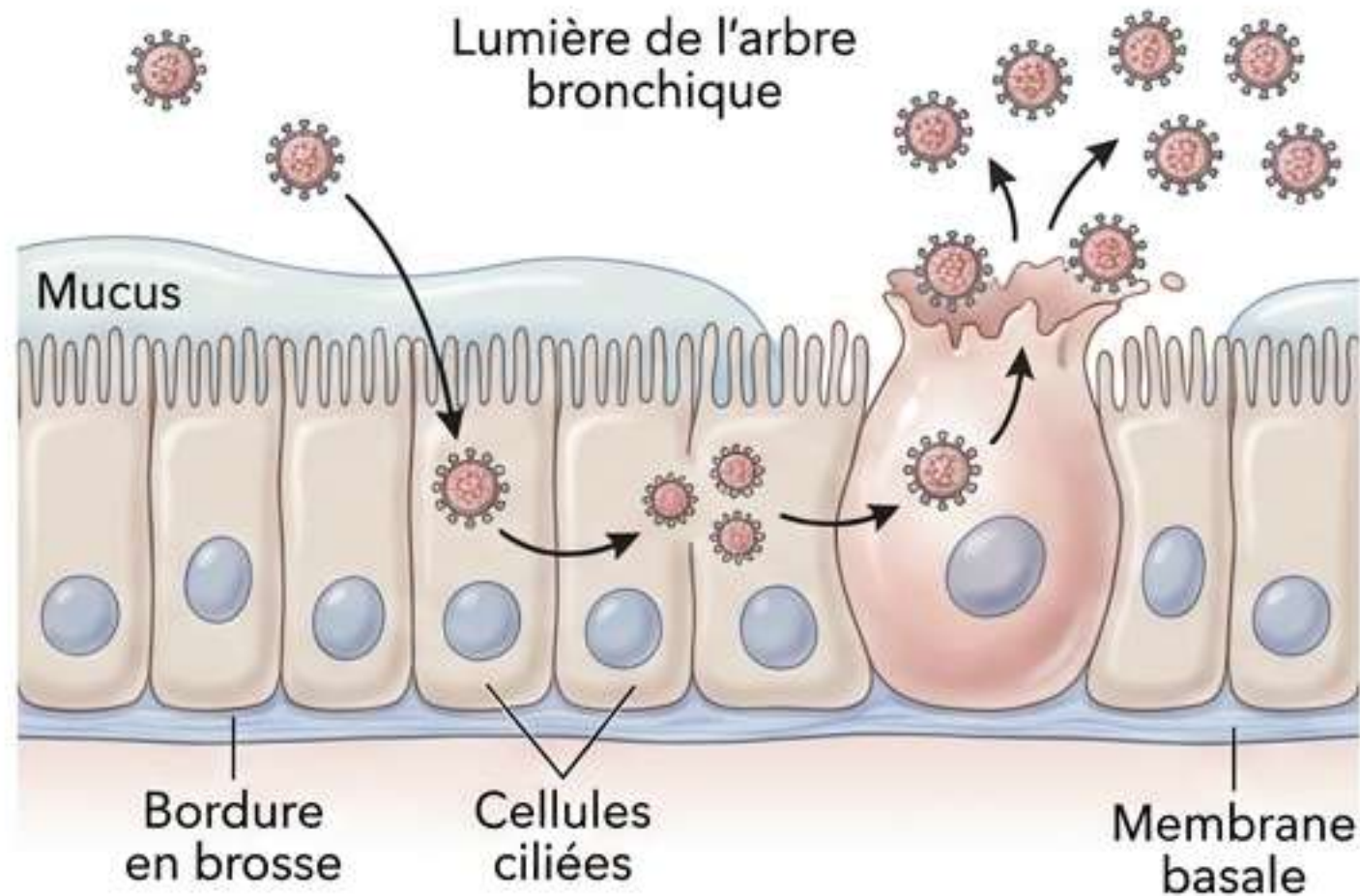
Site de multiplication = Porte d'entrée (Infection locale) -> Période d'incubation COURTE. [Ref: Q3]
Exp: Grippe.

Site de multiplication distinct de la porte d'entrée (Infection générale) -> Période d'incubation LONGUE (semaines/mois). [Ref: Q3]
Exp: Hépatites, VIH.

Diffusion Virale : Locale vs Systémique

Diffusion Locale

Multiplication locale puis rejet direct dans le milieu extérieur (Exp: respiratoire - rhinovirus, influenzaeavirus).

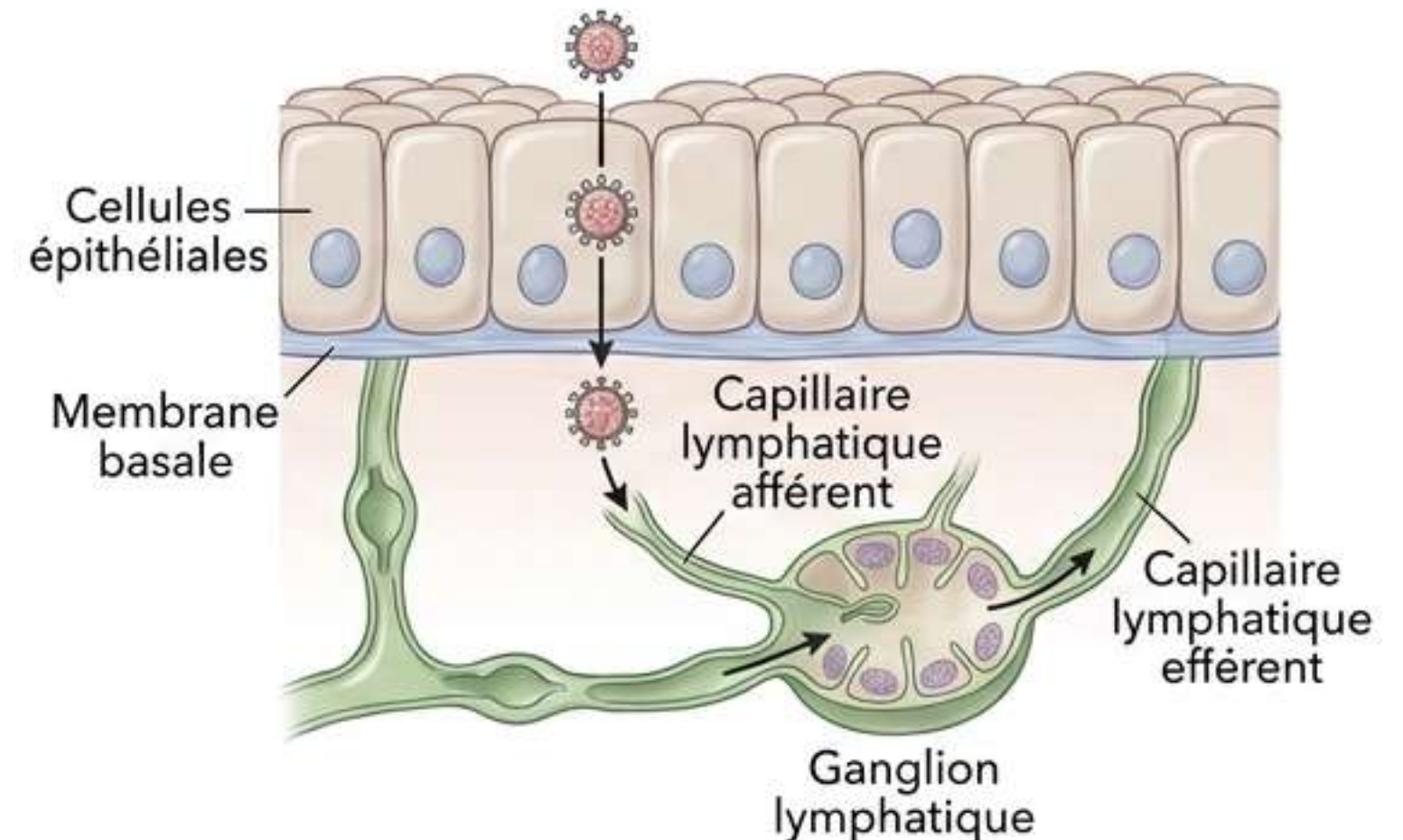


Diffusion Systémique

Sanguine et lymphatique. Véhicule le virus vers les organes cibles.

Transport libre dans le plasma : HBV, HCV, HIV. [Ref: Q6]

Transport associé aux cellules : CMV, EBV, HIV.

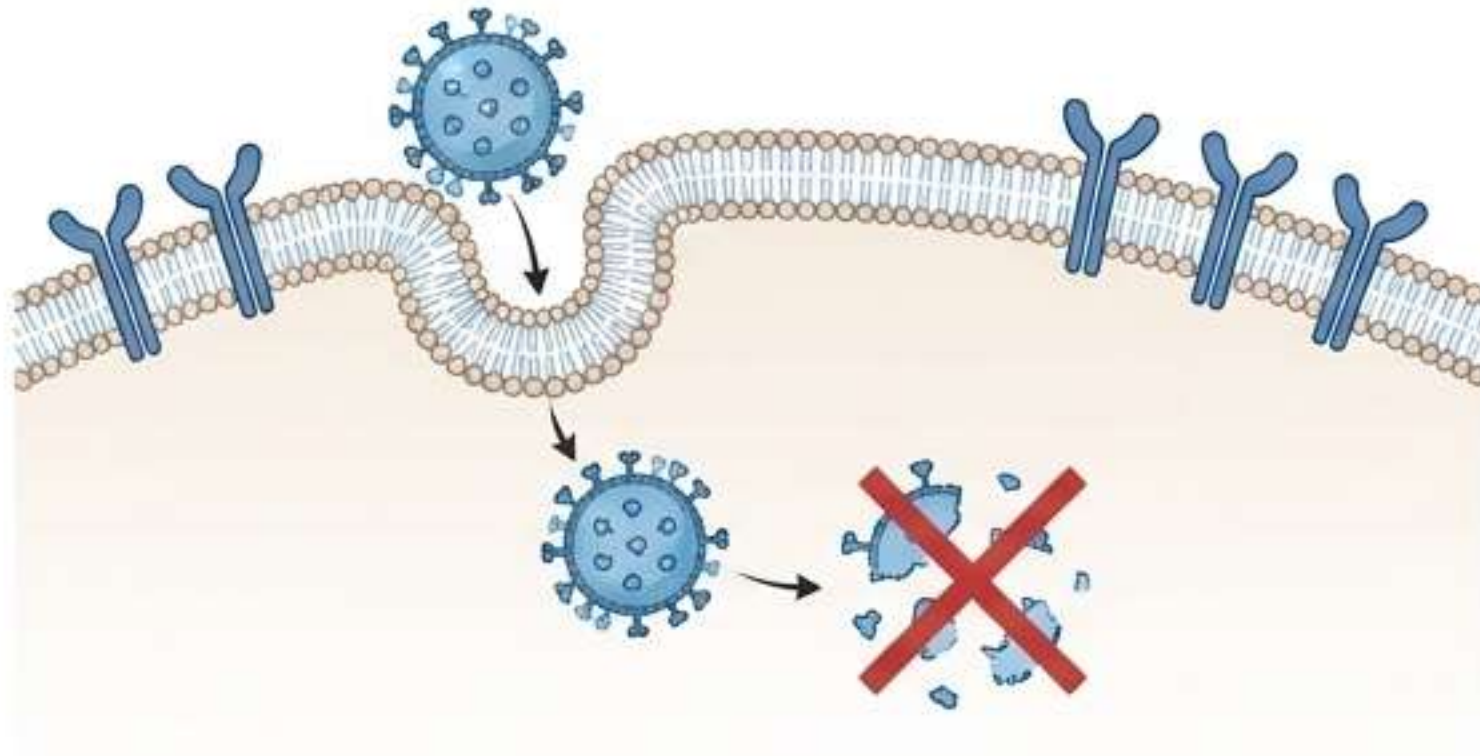


L'Organe Cible : Déterminants du Tropisme Cellulaire

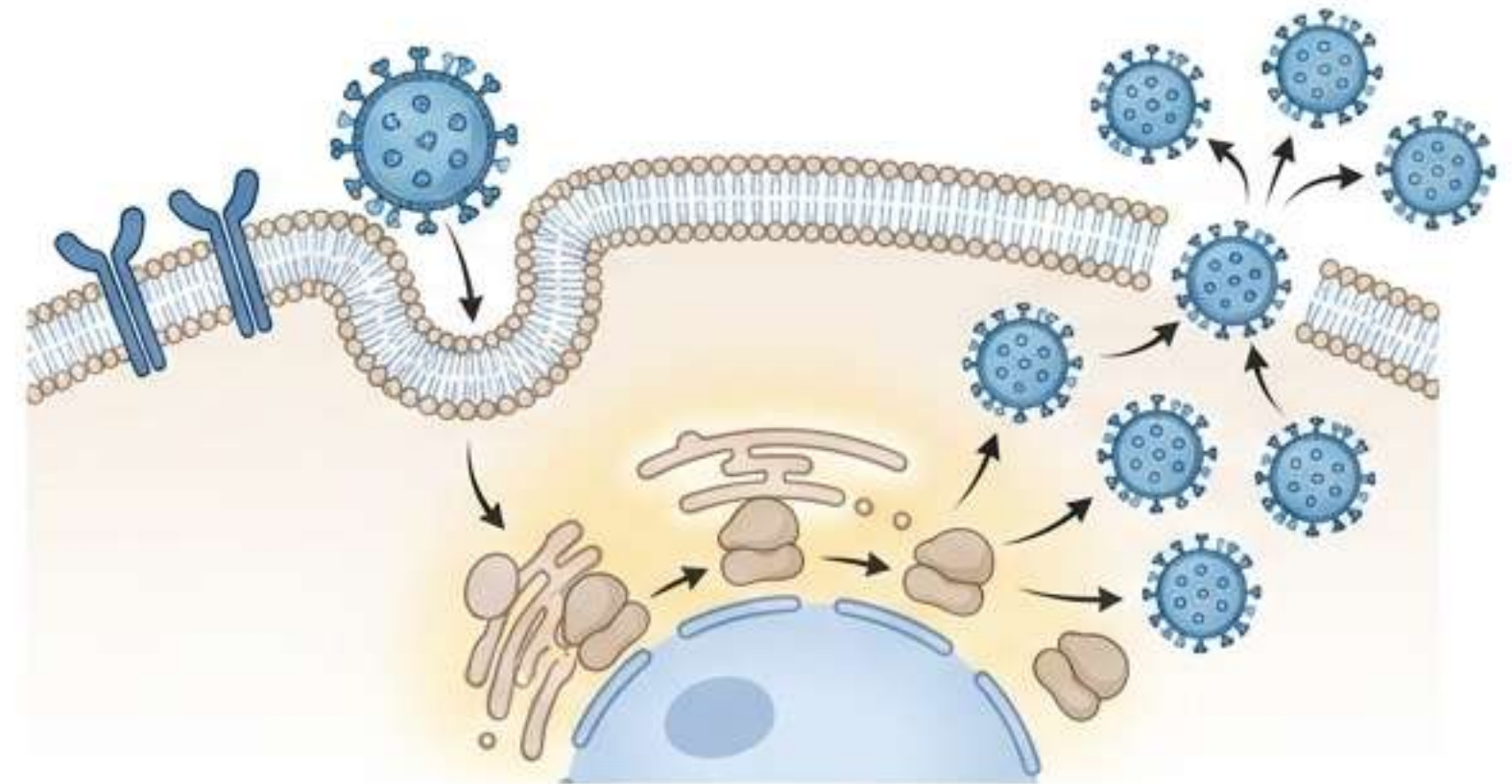


Axiome d'examen : Une cellule sensible n'est pas obligatoirement permissive.
(Corollaire : Une cellule permissive est obligatoirement sensible). [Ref: Q4]

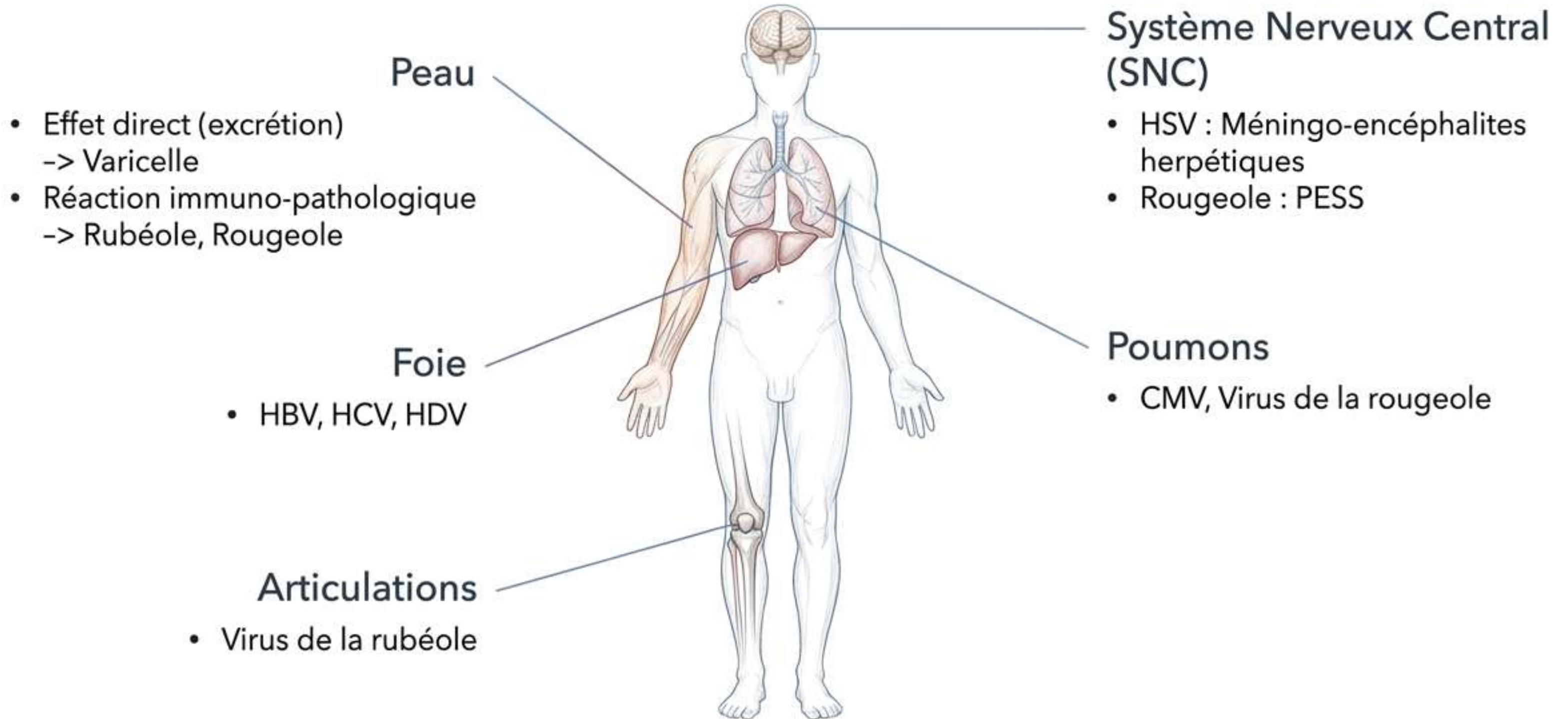
Cellule Sensible MAIS NON Permissive



Cellule Sensible ET Permissive



Manifestations Cliniques par Organe

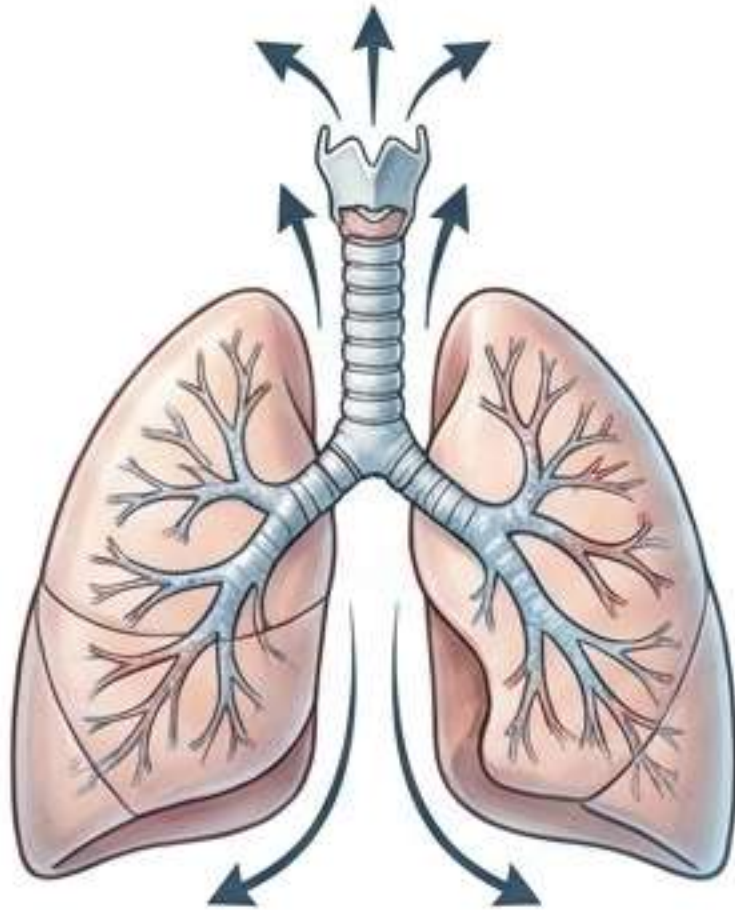


Voies d'Excrétion Virale

Plusieurs voies d'excrétion existent pour permettre la dissémination dans l'environnement et la contamination d'un nouvel hôte.

Voies formellement documentées dans le cours.

[Ref: Q2 - Attention au piège de l'examen sur les fausses voies d'excrétion]



Respiratoire

Grippe, oreillon, rougeole, rubéole



Salive

CMV, EBV

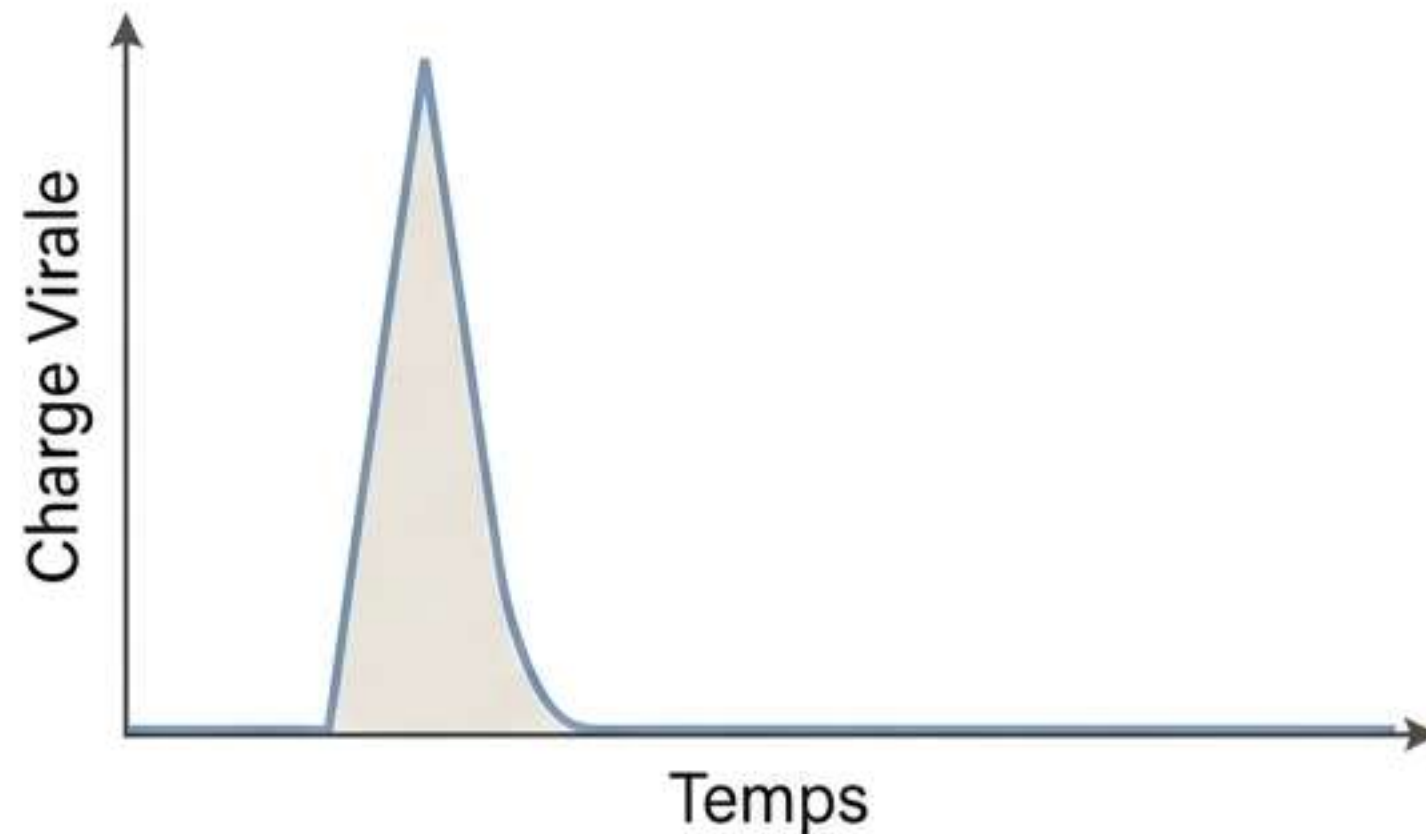


PIÈGE D'EXAMEN

Les virus ne sont PAS excrétés par la sueur.

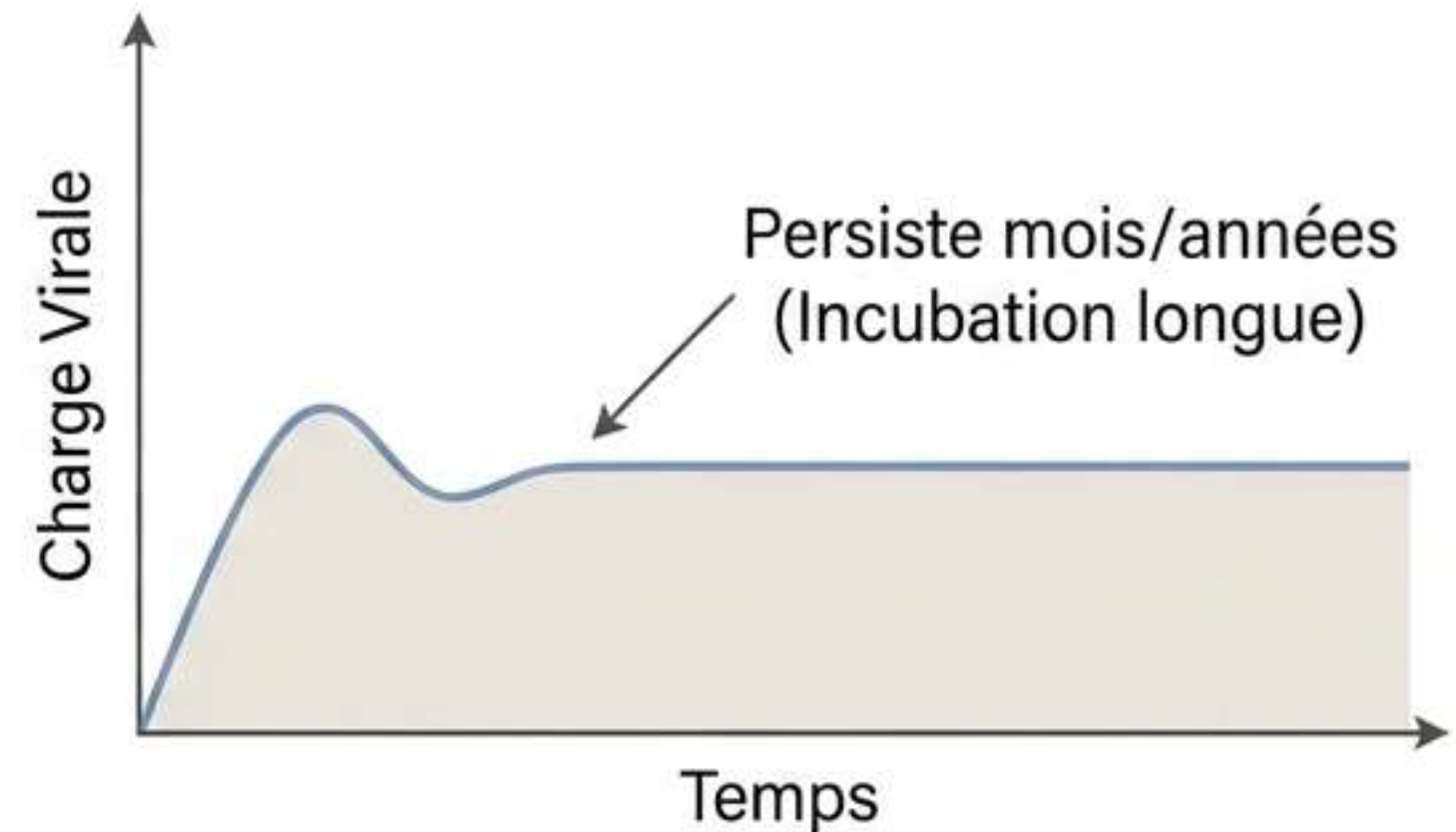
Évolution des Infections Virales : Aiguë vs Persistante

Infection Aiguë



- Souvent asymptomatique.
- Multiplication limitée dans le temps, intense et rapide.
- Excrétion rapide suivie d'une réponse immunitaire (anticorps protecteurs).

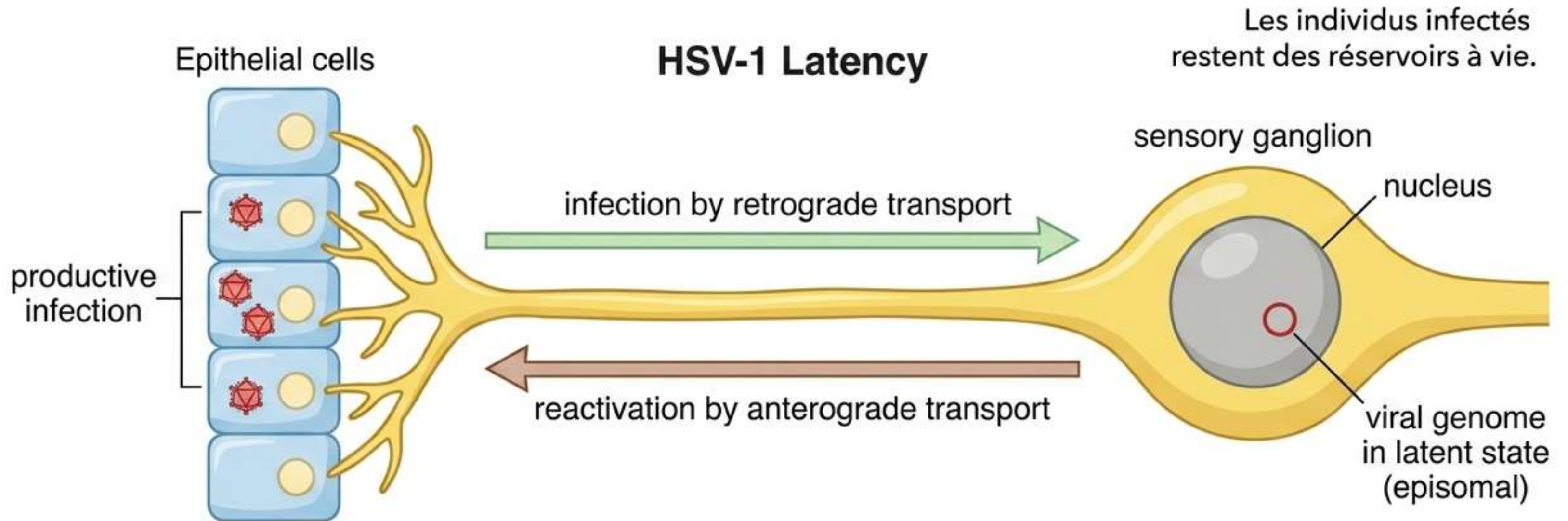
Infection Persistante Chronique



- Fait suite à une infection aiguë.
- Présence continue du virus dans l'organisme (sang, tissus, organes).
- Exemples : HBV, HCV.

Évolution : Infection Latente ou Récurrente

Épisodes aigus séparés par des phases de dormance. Durant la dormance, le virus n'est PAS retrouvé sous forme particulière. [Ref: Q7] Exemples : HSV, VZV.

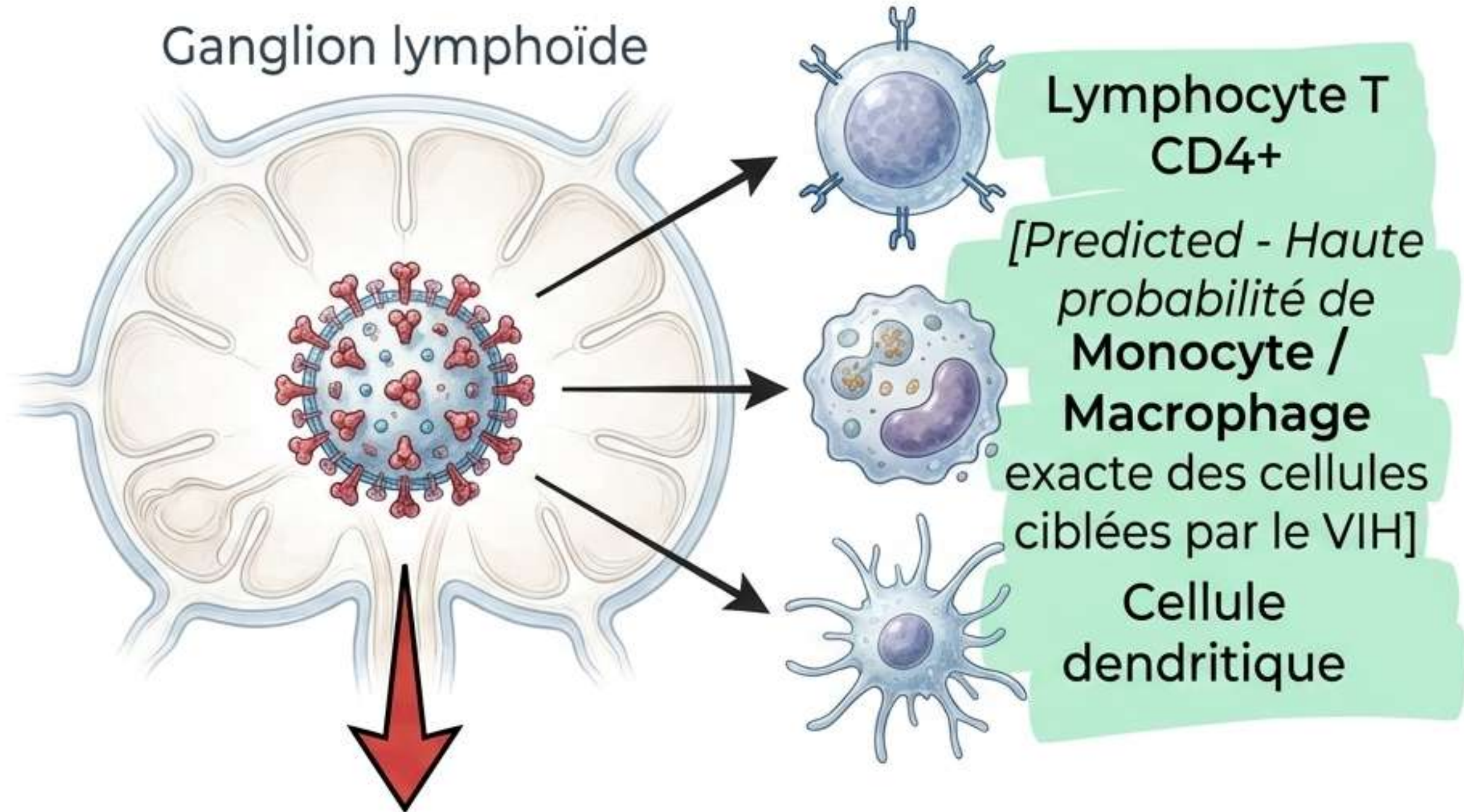


Évolution : Infection Lente et Déficits Immunitaires

Infection Lente :

Incubation très longue.
Multiplication virale très lente avec parasitisme progressif. Évolution insidieuse et fatale.

Exp : VIH/sida, virus rougeoleux (PESS).



**Destruction de TOUT le système immunitaire
(Déficit majeur définitif)**

(Déficits modérés et transitoires : exp. virus de la rougeole)

Exam Pattern Analysis : Stratégie de Révision

Highest Yield (Concepts Répétés)



- Incubation locale vs systémique (Corrélation Porte d'entrée = Site multiplication).
- Dynamique de la Latence (Disparition de la forme particulière HSV/VZV).
- Sensibilité n'équivaut pas à Permissivité.

Le Piège Absolu (The Trap)



Le Réservoir de la Grippe
Le Réservoir de la Grippe
Bien que l'actualité cite les oiseaux/porcs, le cours désigne formellement l'Homme comme réservoir principal.
Cochez selon le PDF !

Prédictions Futures



- Mécanisme de transmission cellule à cellule (échappement immunitaire).
- La triade cellulaire ciblée par le VIH (Lym T CD4+, Macrophages, Dendritiques).

Mind Map Final : Physiopathologie des Infections Virales

